Note de deux pages pour les responsables publics (traduction provisoire)

Traduction provisoire, non relue par une personne de langue maternelle française.

Avertissement sur la traduction

Traduction provisoire du document 50, qu'aucune personne de langue maternelle française n'a encore relue. Faites-la vérifier par une personne qualifiée avant tout usage officiel. En cas de doute, reportez-vous au document 50 (anglais).

Le problème

Les chutes sont la deuxième cause de décès par traumatisme involontaire dans le monde, et près de 40 % des années de vie ajustées sur l'incapacité (années de vie en bonne santé perdues à cause de la maladie, du handicap ou d'un décès prématuré) perdues à cause des chutes concernent des enfants [S45]. La plupart des chutes d'enfants ne sont pas mortelles : elles figurent parmi les principales causes de blessures non mortelles chez l'enfant [S46]. Les commerces, les centres commerciaux et les autres bâtiments ouverts au public ne représentent qu'une partie de ce tableau, et aucune donnée internationale ne dit quelle part. Là où des données existent pour le commerce de détail, les dangers ordinaires comptent : aux États-Unis, environ 24 000 enfants de moins de 15 ans par an ont été soignés aux urgences pour des blessures liées aux chariots de supermarché (moyenne 1990–2011), le plus souvent à la tête [S31].

Ce que propose Child-Safer Spaces

Une trousse de planification gratuite, utilisable hors ligne, destinée aux commerces et aux bâtiments publics fréquentés par des enfants. Elle aide un site à repérer et corriger les dangers liés aux sols, aux chariots et aux arêtes des présentoirs, à vérifier les changements proposés au regard des règles locales, à mener un petit projet pilote responsable et à décider honnêtement de la suite. Elle est **axée sur la performance** (elle dit ce qu'une solution doit accomplir et comment on le vérifiera) et **neutre quant aux matériaux** (elle ne recommande aucun produit). Elle fonctionne sans compte, sans réseau et sans pistage ; les données de planification restent sur l'appareil de la personne qui l'utilise.

Ce qu'elle n'est pas

- Ni une norme, ni une certification, ni un avis juridique, ni une autorisation. Elle ne remplace jamais les règles de construction, d'incendie, d'accessibilité, de santé et sécurité au travail, de sécurité des produits ou de protection de la vie privée.
- Elle n'a pas fait la preuve qu'elle réduit les blessures : aucune évaluation des résultats n'a été menée à terme. Un essai randomisé de revêtements de sol souples chez des personnes âgées n'a pas montré moins de blessures graves dues aux chutes [S8], et les sols souples peuvent rendre plus difficile la poussée des chariots et des fauteuils roulants [S35]. Les essais des surfaces d'aires de jeux ne s'appliquent pas aux allées des magasins [S7].
- Ce n'est pas une raison de recueillir des données sur les enfants, les personnes qui les accompagnent ou le personnel. La trousse n'utilise que des informations agrégées et non identifiantes.

Pourquoi elle concerne votre mandat

Si votre mandat porte sur	L'engagement concerné	Ce que propose la trousse
Handicap et accessibilité	CDPH, article 9 : accès aux installations ouvertes au public, y compris celles gérées par des entités privées ; article 4(3) : consulter les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire de leurs organisations [S48]	Une règle : aucun changement de sécurité ne doit réduire l'accessibilité ; un processus de consultation (W06)
Espaces publics et politique urbaine	Cible 11.7 des ODD : des espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées [S49]	Des méthodes à l'échelle du site, comme contexte de politique publique (l'indicateur des ODD mesure les espaces ouverts urbains, pas les magasins)
Santé et sécurité au travail	Un milieu de travail sûr et salubre est un principe fondamental de l'OIT depuis 2022 [S54]	Le nettoyage, la manutention des chariots et l'ergonomie font partie de chaque évaluation (document 30)
Prévention des traumatismes et santé publique	Les stratégies de prévention de l'OMS mettent l'accent sur des environnements plus sûrs, la formation, la recherche et les politiques [S45]	Un protocole d'évaluation qui reconnaît honnêtement ses limites statistiques (documents 15 et 35)

À quoi pourrait ressembler une adoption

1. Vous ou une ou un collègue lisez cette note et la trousse d'adaptation (document 53). Aucun engagement n'est nécessaire.
2. Une personne responsable sur place consigne les lois et normes applicables et les parties à consulter : organisations de personnes handicapées, représentants du personnel, familles et entreprises, y compris les petites (étape G2).
3. Quelques sites mènent un projet pilote volontaire, avec des responsables désignés, une réserve pour le retrait et une évaluation indépendante (étapes G0 à G5).
4. Les promoteurs décident par écrit d'arrêter, de modifier ou d'étendre, à partir des résultats et de leur incertitude (étape G6). Les petits projets pilotes ne peuvent généralement pas démontrer une baisse des blessures ; le document 35 explique pourquoi.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant

- Transmettre cette note aux personnes chargées des politiques de construction, de travail, de sécurité des produits et de santé publique.
- Désigner une personne-ressource capable de répondre à la question « quelles règles s'appliquent ici ? » pour les sites pilotes.
- Offrir un lieu où les organisations de personnes handicapées, de travailleurs et de familles peuvent examiner les propositions.
- Si vous financez ou réunissez des projets pilotes, demander des rapports honnêtes sur les coûts, les effets indésirables et les résultats nuls, plutôt que des résultats positifs.

Les décisions qui vous reviennent

Les lois et éditions applicables ; l'opportunité d'une éventuelle exigence future, uniquement par vos processus habituels de consultation et de réglementation ; les règles de protection de la vie privée et d'éthique de la recherche ; le financement ; et les versions linguistiques officielles. Les cases cochées dans l'espace de travail ne valent jamais autorisation.

Garde-fous

Aucune donnée personnelle, aucune surveillance, aucune mesure coercitive contre des personnes, et aucune mise en cause des parents ou des personnes qui accompagnent les enfants. Un changement qui aide les enfants ne doit pas rendre un lieu plus difficile à utiliser pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes malvoyantes, les personnes âgées ou le personnel.

À lire ensuite

Le document 20 (proposition aux gouvernements et à la santé publique, États-Unis et Canada), le document 53 (adapter la trousse à un autre pays ou à une autre organisation), le document 54 (d'un site à plusieurs, et comment aider) et le registre des preuves dans l'espace de travail. Ces documents ne sont disponibles qu'en anglais pour le moment.

Sources

1. **S7** ASTM F1292-26 Impact attenuation of surfacing materials within the use zone of playground equipment (public scope). ASTM International, F1292-26, active (page updated 2026-09-14). https://store.astm.org/f1292-26.html
2. **S8** Mackey DC et al. (2019) FLIP randomized trial of compliant flooring in long-term care. PLoS Medicine 16(6): e1002843. PLoS Medicine (peer reviewed), Published 2019. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002843
3. **S31** Martin K, Chounthirath T, Xiang H, Smith GA (2014) Pediatric shopping-cart-related injuries treated in US emergency departments, 1990–2011. Clinical Pediatrics 53(3):277–285. Clinical Pediatrics (peer reviewed); abstract via PCOM Digital Commons, Published 2014. https://digitalcommons.pcom.edu/scholarly_papers/198
4. **S35** Lachance CC et al. (2017) Compliant flooring to prevent fall-related injuries in older adults: a scoping review. PLoS ONE 12(2): e0171652. PLoS ONE (peer reviewed), Published 2017. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171652
5. **S45** Falls (fact sheet). World Health Organization, 2021-04-26. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls
6. **S46** World report on child injury prevention, chapter 1: Child injuries in context. World Health Organization and UNICEF (NCBI Bookshelf copy); editors Peden M, Oyegbite K, Ozanne-Smith J and others, 2008. https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310643
7. **S48** Convention on the Rights of Persons with Disabilities (articles 4 and 9). United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, General Assembly resolution A/RES/61/106 (2006). https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
8. **S49** Sustainable Development Goal 11: targets 11.2 and 11.7. United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2030 Agenda (adopted 2015); page as published. https://sdgs.un.org/goals/goal11
9. **S54** Statement for World Day for Safety and Health at Work 2025 (ILO Office for Türkiye). International Labour Organization, 2025-04-28. https://www.ilo.org/resource/statement/we-need-come-together-renew-our-commitment-occupational-safety-and-health

Zero Harm & Anti-Coercion. These materials exist to prevent injury and widen access. Do not use them to blame or surveil caregivers, children, workers or disabled visitors, to pressure anyone into taking part, or to hide unfavourable findings. This page makes no network connections and contains no tracking.